

ASPIRAÇÃO — QUÍMICA ou BACTERIANA?

PNEUMONITE QUÍMICA vs PNEUMONIA ASPIRATIVA

Aspecto	Pneumonite química (Mendelson)	Pneumonia aspirativa
Mecanismo	Lesão química do ácido gástrico aspirado	Infecção por aspiração de flora orofaríngea
Início	Agudo (minutos a horas após a aspiração)	Insidioso (dias)
Conteúdo	Estéril e ácido (pH baixo)	Colonizado por bactérias da boca
Febre/leucocitose	Pode haver inicialmente (inflamação), tende a regredir	Febre e leucocitose persistentes
Antibiótico	NÃO de rotina — observar 48-72h	SIM — cobertura de flora oral/anaeróbios
Evolução	Muitas vezes melhora espontânea ou progride para SDRA	Pode evoluir com abscesso/empiema

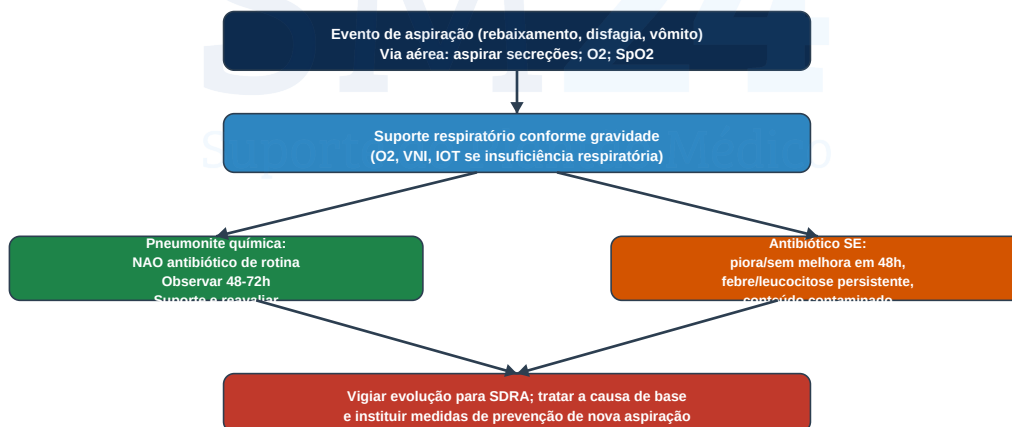
O ERRO MAIS COMUM

NEM TODA ASPIRAÇÃO PRECISA DE ANTIBIÓTICO

- A pneumonite química (Mendelson) é uma lesão inflamatória **ESTÉRIL** pelo ácido — não é infecção
- Antibiótico de rotina na pneumonite química seleciona resistência sem benefício
- Conduta inicial: suporte (O₂, aspiração de via aérea, ventilação se necessário) e **OBSERVAÇÃO** por 48-72h
- Iniciar antibiótico se: não melhora ou piora em 48h, febre/leucocitose persistentes, ou aspiração de conteúdo claramente contaminado (obstrução intestinal, conteúdo fecaloide)
- Corticoide **NÃO** é recomendado de rotina
- Aspiração de grande volume e baixo pH pode evoluir para SDRA — vigiar a oxigenação

MANEJO DA ASPIRAÇÃO TESTEMUNHADA

ASPIROU — SUPORTE + OBSERVAR



ANTIBIÓTICO QUANDO INDICADO

Cenário	Esquema	Observação
Pneumonia aspirativa comunitária	Amoxicilina-clavulanato OU ampicilina-sulbactam	Cobre flora oral e anaeróbios
Alergia a betalactâmico	Clindamicina (+/- quinolona respiratória)	Boa cobertura de anaeróbios
Aspiração hospitalar / grave	Piperacilina-tazobactam OU carbapenêmico	Considerar Gram-negativos e MRSA conforme risco
Abscesso pulmonar	Amoxicilina-clavulanato ou clindamicina prolongados	Drenagem se necessário
Cobertura anaeróbia rotineira	Reservar para periodontite grave, abscesso, empiema, conteúdo necrótico	Nem toda aspiração precisa de anaeróbica

FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO

Fatores de Risco

- Rebaixamento do nível de consciência (AVC, intoxicação, pós-ictal, anestesia)
- Disfagia (doença neurológica, idoso, demência)
- Doença do refluxo, obstrução intestinal, sonda nasogástrica
- Vômitos, intubação/extubação, endoscopia
- Má higiene oral e periodontite (maior carga bacteriana)

Prevenção

- Cabeceira elevada (30-45 graus) em acamados e em ventilação mecânica
- Avaliação fonoaudiológica da deglutição em risco de disfagia
- Higiene oral rigorosa (reduz a carga bacteriana)
- Cuidados com a dieta (consistência, posicionamento)
- Manejo do refluxo e revisão de sedação excessiva
- Técnica adequada de intubação/sonda e jejum pré-procedimento

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Diferenciar pneumonite química (estéril, aguda) de pneumonia aspirativa (infecciosa, tardia)
- ☐ Suporte respiratório imediato: aspirar via aérea, O2, ventilação conforme gravidade
- ☐ Pneumonite química: NÃO antibiótico de rotina — observar 48-72h
- ☐ Antibiótico se piora/sem melhora em 48h, febre/leucitose persistente ou conteúdo contaminado
- ☐ Vigiar evolução para SDRA (aspiração volumosa e muito ácida)
- ☐ Tratar a causa de base e implementar prevenção (cabeceira elevada, avaliação da deglutição, higiene oral)

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com rebaixamento por intoxicação alcoólica aspira conteúdo gástrico. Apresenta hipoxemia, mas sem febre nem leucocitose. Qual a conduta inicial?

- A) Antibiótico de amplo espectro imediato
- B) Suporte respiratório e observação por 48-72h, sem antibiótico de rotina (pneumonite química)
- C) Corticoide em altas doses
- D) Lavagem brônquica com antibiótico
- E) Alta imediata

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual a principal diferença entre pneumonite química e pneumonia aspirativa?

- A) A pneumonite química é infecciosa e a aspirativa é estéril
- B) A pneumonite química é uma lesão estéril aguda pelo ácido, e a pneumonia aspirativa é uma infecção por flora oral de início mais tardio
- C) Ambas são tratadas igualmente com antibiótico de rotina
- D) A pneumonia aspirativa nunca causa abscesso
- E) A pneumonite química exige sempre corticoide

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Em qual situação a aspiração JUSTIFICA antibiótico precoce?

- A) Toda aspiração testemunhada
- B) Aspiração de conteúdo claramente contaminado (ex.: obstrução intestinal/fecaloide) ou ausência de melhora em 48h com febre/leucocitose persistentes
- C) Apenas quando a SpO2 está normal
- D) Somente em pacientes jovens
- E) Nunca se deve usar antibiótico na aspiração

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual medida é eficaz na PREVENÇÃO de aspiração em pacientes acamados e em ventilação mecânica?

- A) Manter o paciente em decúbito horizontal
- B) Elevar a cabeceira a 30-45 graus
- C) Suspender a higiene oral
- D) Sedação profunda contínua
- E) Aumentar o volume da dieta enteral em bolus

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Paciente idoso com disfagia evolui em 3 dias com febre, tosse produtiva e leucocitose após episódios de engasgo. Qual o diagnóstico e o antibiótico de escolha?

- A) Pneumonite química — sem antibiótico
- B) Pneumonia aspirativa — amoxicilina-clavulanato (ou ampicilina-sulbactam)
- C) Tuberculose — esquema RIPE
- D) Embolia pulmonar — anticoagulação
- E) Asma — broncodilatador

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Aspiração de conteúdo gástrico em paciente rebaixado, com hipoxemia mas sem febre/leucocitose, caracteriza pneumonite química (Mendelson) — lesão estéril. Conduta: suporte respiratório e observação por 48-72h, SEM antibiótico de rotina. Reavaliar e tratar se houver sinais de infecção.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A pneumonite química é uma lesão inflamatória ESTÉRIL e aguda causada pelo ácido gástrico aspirado; a pneumonia aspirativa é uma INFEÇÃO por flora orofaríngea, de instalação mais tardia. A distinção define a necessidade de antibiótico.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Antibiótico precoce na aspiração se justifica quando o conteúdo aspirado é claramente contaminado (obstrução intestinal, conteúdo fecaloide) ou quando não há melhora em 48h com febre e leucocitose persistentes, sugerindo infecção (pneumonia aspirativa).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Elevar a cabeceira a 30-45 graus reduz o refluxo e a microaspiração, sendo medida eficaz de prevenção em acamados e pacientes em ventilação mecânica. Higiene oral rigorosa e avaliação da deglutição também são fundamentais.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Evolução em dias com febre, tosse produtiva e leucocitose após engasgos em idoso disfágico caracteriza pneumonia aspirativa (infecção por flora oral/anaeróbios). O tratamento de escolha é amoxicilina-clavulanato ou ampicilina-sulbactam (clindamicina se alergia a betalactâmico).

SM24
Suporte ao Plantão Médico